PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

LIDOCAÍNA HCl

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: Hidrocloridrato de lidocaína; Lidocaína HCl; Cloridrato de lidocaína monoidratado; cloridrato de Xilocaína monoidratado; Lidocaína hidroclorídrica.

CAS: 6108-05-0

DCB: 11386

FORMULA MOLECULAR: $C_{14}H_{22}N_2O.HCl.H_2O$

PESO MOLECULAR: 288,8

USO: Tópico.

INFORMAÇÕES GERAIS: Lidocaína hidrocloridrato é um anestésico local comum e um medicamento antiarrítmico. É frequentemente utilizado em procedimentos médicos e dentários para adormecer uma área específica do corpo e prevenir a dor. A lidocaína funciona bloqueando os sinais nervosos no corpo. Está disponível em várias formas, incluindo injeções, cremes, géis e sprays. Além de suas propriedades anestésicas, a lidocaína também é usada para tratar batimentos cardíacos irregulares (arritmias). É importante usar a lidocaína sob a orientação de um profissional de saúde devido aos possíveis efeitos colaterais e interações com outros medicamentos.

O efeito anestésico da Lidocaína HCl geralmente dura de 60 a 75 minutos.

INDICAÇÃO: O cloridrato de lidocaína monoidratado é usado em uma variedade de situações clínicas e procedimentos médicos, devido às suas propriedades anestésicas. Tem como principais indicações para:

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

- ✓ Anestesia local;
- ✓ Anestesia Tópica;
- ✓ Redução da dor de ferimentos leves ou cortes;
- ✓ Alívio sintomático da dor associada à cistite e uretrite;
- ✓ Anestesia de superfície para uretra feminina e masculina durante procedimentos como cistoscopia, cauterização, sondagem e outros procedimentos endouretrais;
- ✓ Intervenções Odontológicas: a lidocaína é frequentemente usada para anestesia local durante procedimentos como extração de dentes, tratamentos de canal radicular, ou aplicação de restaurações dentárias.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: Tópico: 2 a 5%.

INSTRUÇÕES FARMACÊUTICAS: Ao dispensar formulações para uso na mucosa oral, é crucial orientar o paciente a não deglutir a lidocaína. O medicamento deve permanecer em contato com a área afetada e, em seguida, fazer um bochecho para evitar a ingestão do ativo.

Obs: Aplique apenas em pele intacta.

SUGESTÃO DE FÓRMULA

Gel Orabase para Aftas

LIDOCAÍNA.....2%
Acetonido de Triancinolona.....0,1%
Iodofórmio..... 1%
Timol.....0,1%
Gel Orabase qsp.....10 g

Modo de usar: Aplicar nas lesões 2 vezes ao dia.
Indicação: Para aftas e ulcerações na mucosa oral.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Lidocaína

LIDOCAÍNA.....2 – 5 %

Creme Excipiente ou Gel qsp.....0,1%

Modo de usar: Aplicar e ocluir por 1 hora, antes do procedimento cirúrgico.

Indicação: Anestésico tópico, tratamentos com laser e depilação.

EFEITOS ADVERSOS

Efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC): Reações psicóticas suspeitas foram relatadas em 6 pacientes que receberam lidocaína intravenosa para o tratamento de distúrbios cardíacos. *(Turner W.; 1982).* Em outro caso,22 pacientes desenvolveram sinais de ataxia cerebral após o uso tópico de lidocaína para endoscopia. Quando comparada com outros anestésicos locais, a lidocaína pode estar associada a um aumento do risco de complicações neurotóxicas quando utilizada para anestesia espinhal. *(Perney P, et al.;2004).*

Efeitos na pele: Eritema e pigmentação no lábio superior em uma criança após infiltração odontológica local de lidocaína foram atribuídos a um tipo de erupção cutânea fixa. Eritema também pode ocorrer após o uso tópico de algumas formulações de lidocaína, como adesivos transdérmicos, enquanto o embranquecimento transitório da pele é frequente após a aplicação de misturas eutéticas de lidocaína/prilocaína na pele. *(Villada G, et al.; 1990).*

Reações de hipersensibilidade verdadeira, incluindo dermatite, são raras mas podem ocorrer.

Superdosagem: Os efeitos mais graves da intoxicação por lidocaína são no SNC e no sistema cardiovascular, e a superdosagem pode resultar em hipotensão grave, assistolia, bradicardia, apneia, convulsões, coma, parada cardíaca, parada respiratória e morte.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

INTERAÇÕES: A depuração da lidocaína pode ser reduzida pelo propranolol e pela cimetidina. Os efeitos depressores cardíacos da lidocaína são adicionais aos dos beta-bloqueadores e de outros antiarrítmicos. Efeitos cardíacos adicionais também podem ocorrer quando a lidocaína é administrada com fenitoína intravenosa; no entanto, o uso prolongado de fenitoína e outros indutores enzimáticos pode aumentar os requisitos de dosagem de lidocaína. A hipocalemia produzida pela acetazolamida, diuréticos de alça e tiazídicos antagoniza o efeito da lidocaína.

FARMACOCINÉTICA: A lidocaína é facilmente absorvida pelo trato gastrointestinal, pelas membranas mucosas e através da pele lesada, com absorção limitada pela pele intacta. Nos locais de injeção, incluindo o músculo, a absorção é rápida.

Após administração intravenosa, a lidocaína é prontamente distribuída nos tecidos altamente vascularizados, com subsequente redistribuição nos músculos esqueléticos e tecido adiposo. Liga-se às proteínas plasmáticas, como a glicoproteína α1-ácida (AAG), em aproximadamente 66%, dependendo das concentrações de lidocaína e AAG. Alterações na concentração de AAG podem afetar significativamente as concentrações plasmáticas de lidocaína.

As concentrações plasmáticas diminuem rapidamente após administração intravenosa, com meia-vida inicial de menos de 30 minutos; a meia-vida de eliminação de 1 a 1,5 horas, podendo ser prolongada com infusões prolongadas ou redução do fluxo sanguíneo hepático. A lidocaína sofre metabolismo extenso no fígado, com cerca de 90% da dose desalquilada para formar monoetilglicinexilidida e glicinexilidida. Esses metabólitos podem contribuir para os efeitos terapêuticos e tóxicos da lidocaína, com possibilidade de acumulação durante infusões prolongadas. Aproximadamente 10% da lidocaína é excretada inalterada na urina.

Pacientes com insuficiência cardíaca, doença hepática alcoólica ou hepatite crônica ou viral podem apresentar depuração reduzida de lidocaína. Drogas que afetam o fluxo sanguíneo

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

hepático ou induzem enzimas microssomais hepáticas podem também afetar sua depuração.

A lidocaína atravessa a barreira placentária e a barreira hematoencefálica, sendo excretada no leite materno.

REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 5ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2015.

CHEMICAL BOOK. Linocaine hydrochloride. ***Base de dados.*** Disponível em: https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB4486868_EN.htm. Acesso em: 12 abril. 2024.

Perney P, et al. ***Ataxia transitória relacionada à lidocaína administrada topicamente.*** Ann Pharmacother 2004; 38: 828–30.

Sweetman Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

Turner WM. ***Lidocaine and psychotic reactions.*** Ann Intern Med 1982; 97: 149–50.

Villada G, et al. **Embranquecimento local após aplicação epicutânea de creme EMLA: um estudo randomizado duplo-cego entre 50 voluntários saudáveis.** Dermatologica 1990; 181: 38–40.

Texto atualizado em 11/04/2024, por Rafael Ramos.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.